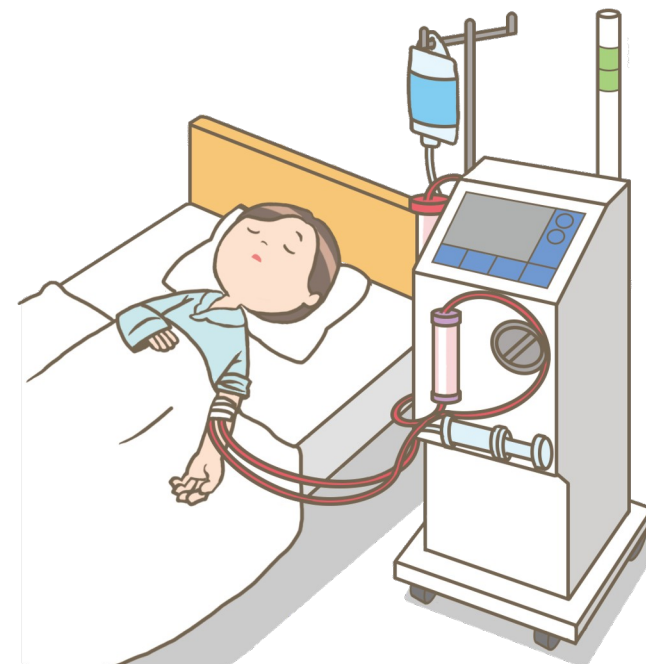


病棟勉強会

～透析のシャントについて知ろう～

透析室教育チーム

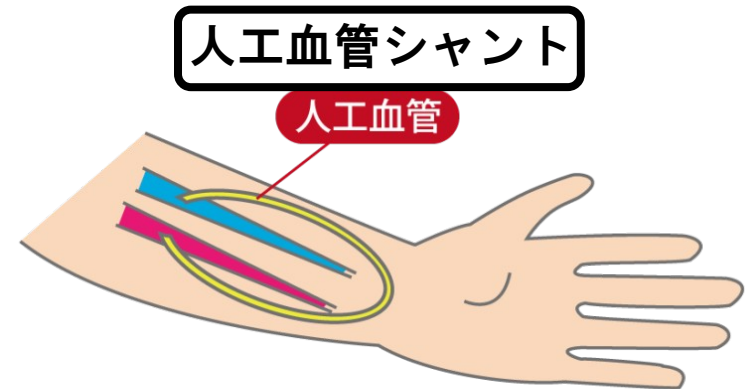
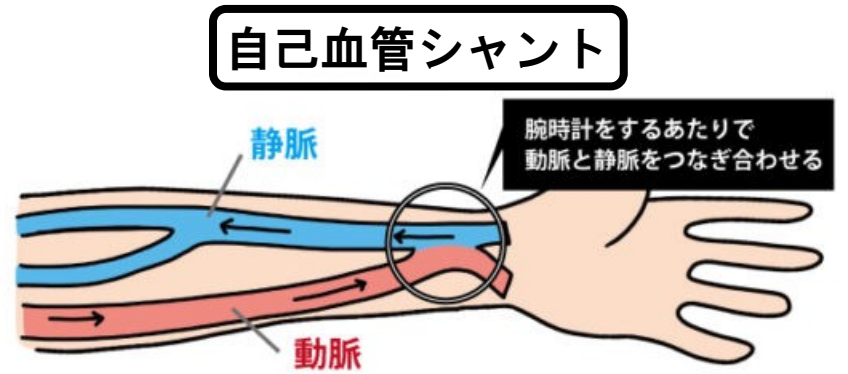
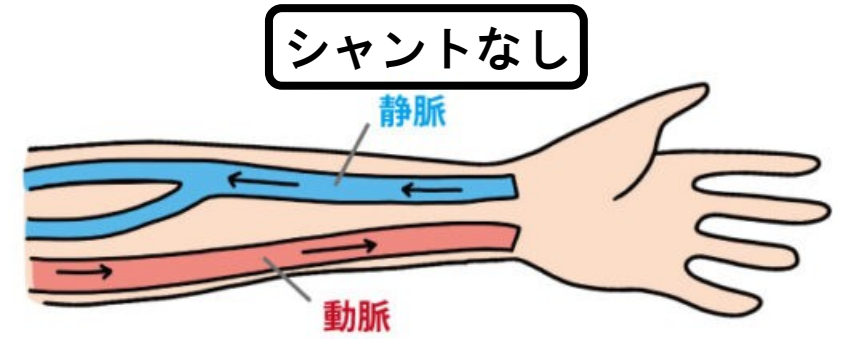
透析とは腎不全になった患者の治療で
人工腎臓を用いて血液中の余分な水分や
老廃物を除去しています



血液を体外循環させるために
一分間で200ml～300mlの血液を
確保し体外循環をしますが
静脈は血流量が少なく、
動脈は穿刺や止血が困難です

動脈と静脈を吻合し
動脈血を流れ込ませた静脈を作成します
→ **シャント** と呼びます

脱血用の針と返血用の針の
二か所の穿刺が必要です



シャント管理の合言葉

みる・きく・さわる

みる  

シャント肢全体の観察をしてください

具体的には

- ・ **感染はないか**（発赤、疼痛、熱感）
- ・ 瘤の状態はどうか
- ・ 傷や内出血はないか
- ・ 浮腫んでいないか など



シャントに聴診器を当てると「ザーザー」といった音が聞こえます

穿刺部（局所麻酔剤を貼る位置）の音を聞いてください

無音の場合、シャント閉塞の可能性があります

※注意点

- ・ 吻合部（上流）が最も大きな音で中枢（下流）に向かうほど音が小さくなります
- ・ 穿刺部が無音の場合、吻合部から中枢に向かって順に音を聞いてください



シャント肢の熱感→感染の可能性があります

“スリル(振動)”を確認→スリルが無い場合、閉塞の可能性があります

シャントに関するカルテの略語の意味は？

- AVF (Arteriovenous fistula)
動脈・静脈の瘻 → 自己血管シャント
- AVG (Arteriovenous graft)
動脈・静脈のグラフト → 人工血管シャント

透析直前に穿刺部を手洗いする理由は？

シャント肢から血管内に細菌が入ると全身感染を起こします
穿刺前に消毒を行っていますが、消毒薬は皮膚に皮脂や汚れが
付着していると十分な消毒効果が得られません



止血バンドと絆創膏を外すタイミングは？

	AM透析	PM透析
止血バンド	夕食後	眠前
絆創膏	眠前	翌朝



抜針後、出血しやすい患者さまは
ややきつめに止血バンドを
巻いておくこともあります。
シャント肢にチアノーゼが出たら
すぐにバンドを緩め、
再度軽めに巻き直してください。

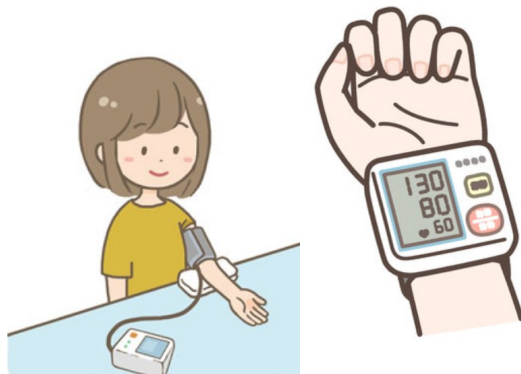
シャント肢での禁止事項は？

シャント肢の圧迫
シャント閉塞リスクの増加

リストバンド・腕時計



血圧測定

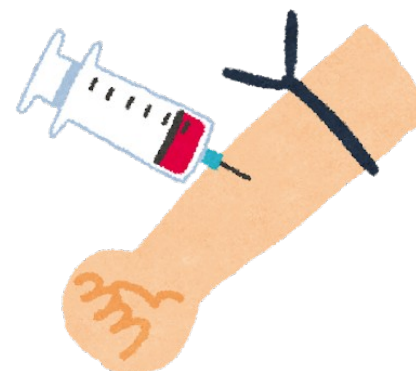


腕枕、荷物をかける



シャント肢の採血
穿刺による血管損傷・止血困難
感染リスクの増加など

採血



なぜ局所麻酔剤を貼るの？いつ、どこに貼ればいいのか？

局所麻酔剤

- ・リドカインテープ
- ・ペンレス
- ・エムラクリーム

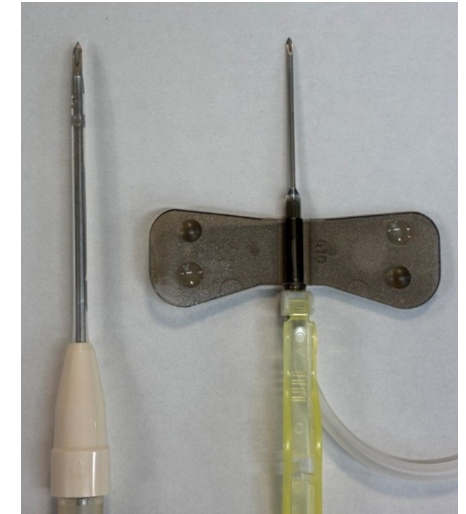
透析時の穿刺による痛みを軽減します
必ずシャントの穿刺部に貼付して下さい
(透析入室時間の1～2時間前)

シャント確認方法

- ・自己血管
軽く駆血を行うとシャントが浮き出してわかりやすいです
- ・人工血管
シャント肢を触れば位置がわかります
閉塞している旧人工血管がある場合もあるので注意が必要です

貼付箇所が不明の場合透析室に連絡してください
マーキングを行います

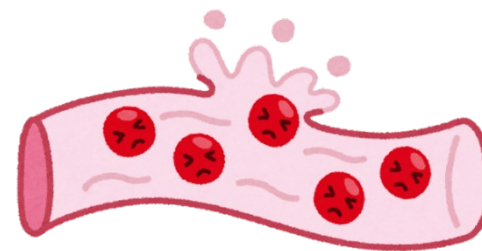
参考：針のサイズ
透析用16G 採血用22G



透析後、穿刺部から出血してきた場合の対応は？

<対応>

- ①滅菌ガーゼを出血部に当てて、用手圧迫を行う(5～10分)
- ②止血バンドを巻く(強め)
- ③止血完了後、絆創膏(インジェクションパッド or ブラッドバン)を貼る
- ④止血バンドを巻き(弱め)、1～2時間経過後止血バンドを外す



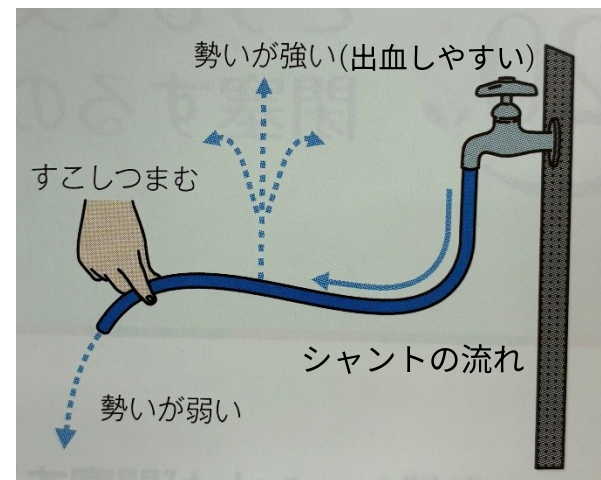
<お願い>

上記の対応①～④を行った患者については
次回の透析前までに透析室に連絡してください

※参考<出血の原因として考えられる可能性>

- ①シャントの狭窄によって、再出血しやすいになっている
- ②肘を曲げたことにより、止血バンドに緩みが生じた
- ③穿刺部に触れたことにより、かさぶたが剥がれた
- ④抗凝固剤の過剰投与

参考：狭窄による出血のイメージ



止血バンド 実践練習

用手止血後の強さ（強め）

バンドを巻いた後、シャント下流側のスリルを感じることができる程度

止血完了後の強さ（弱め）

圧迫痕が出ない程度

手を動かしてもバンドがずり落ちてこない程度